

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. DENOMINATION DU MÉDICAMENT

RANTUDIL 90 Retard 90 mg, gélules à libération prolongée

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chaque gélule à libération prolongée contient 90 mg d'acémétacine.

Excipient(s) :

Lactose monohydraté - 63 mg

Tartrazine (E102) - 0,072 mg-0,096 mg

Pour la liste complète d'excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Gélule à libération prolongée.

Gélule de gélatine, tête vert foncé et corps orange, avec impression « Rantudil 90 Retard/Bial ».

4. DONNÉES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques

Traitement symptomatique de situations douloureuses/inflammatoires aiguës ou chroniques et d'exacerbations de pathologie chronique, notamment :

- Affections rhumatismales (arthrite rhumatoïde, spondylarthrites séronégatives).
- Tendinites, ténosynovites, bursites.
- Crises de goutte aiguës, lumbago, sciatique.
- Ostéoarthrose.
- Situations traumatiques : distensions, entorses, contusions.

4.2 Posologie et mode d'administration

La dose moyenne normale pour l'adulte est d'une gélule à libération prolongée de RANTUDIL 90 Retard, 1 à 2 fois par jour.

Les gélules à libération prolongée doivent être ingérées entières, avec un peu de liquide, de préférence suivant la consommation d'un aliment. La survenue d'effets indésirables peut être minimisée par l'utilisation de la dose minimale efficace pendant la durée la plus courte possible nécessaire au soulagement des symptômes (cf. section 4.4).

Insuffisance rénale et hépatique

Prendre des précautions lors de l'administration d'un AINS à des patients souffrant d'insuffisance rénale et hépatique. Chez les patients atteints de dysfonction rénale et hépatique légère à modérée,

la dose initiale devra être réduite. Ne pas administrer l'acémétacine aux patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique grave (voir section 4.3).

Enfants et adolescents

La prise de RANTUDIL 90 Retard n'est pas recommandée aux enfants et adolescents âgés moins de 14 ans.

4.3 Contre-indications

Hypersensibilité à l'acémétacine ou à l'un des excipients.

Histoire d'hémorragie gastro-intestinale ou perforation associée à la thérapeutique précédente à base d'AINS. Ulcère peptique/hémorragie active ou histoire d'ulcère peptique/hémorragie récurrente (deux ou plusieurs épisodes différents d'ulcération ou hémorragie prouvée).

En cas d'insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque grave (voir section 4.4).

Comme tout autre anti-inflammatoire non-stéroïde (AINS), RANTUDIL 90 Retard est également contre-indiqué aux patients dont les crises d'asthme, d'urticaire ou de rhinite aiguë sont provoquées par l'acide acétylsalicylique ou par tout autre AINS.

Patients présentant une hémorragie cérébrovasculaire ou d'autres hémorragies actives.

Patients atteints de modifications inexpliquées de l'hématopoïèse ou du système de coagulation.

Dernier trimestre de grossesse (voir section 4.6).

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Il est possible de minimiser les effets indésirables en administrant la dose minimale efficace pendant la durée la plus courte possible nécessaire pour contrôler les symptômes (voir section 4.2. et les informations sur les risques GI et cardiovasculaires indiqués ci-dessous).

Patients âgées

Les personnes âgées présentent plus fréquemment des réactions adverses aux AINS, notamment des cas d'hémorragies gastro-intestinales et de perforations, lesquelles peuvent s'avérer être fatales.

Hémorragie, ulcération et perforation gastro-intestinale

Des cas d'hémorragie, d'ulcération et de perforation gastro-intestinale potentiellement fatale ont été rapportés avec tous les AINS, à plusieurs phases du traitement, qu'ils soient ou non associés à des symptômes d'alerte ou histoire d'événements gastro-intestinaux graves. Le risque d'hémorragie, d'ulcération ou de perforation est plus grand avec des doses élevées d'AINS, chez les patients ayant une histoire d'ulcère peptique, particulièrement associée à l'hémorragie ou perforation (voir section 4.3), et chez les patients âgés.

Dans ces cas, les patients devront être avertis d'informer leur médecin de la survenue de symptômes abdominaux et d'hémorragie digestive, surtout au cours des phases initiales du traitement.

Chez ces patients, commencer le traitement par la dose minimale efficace. La coadministration d'agents protecteurs (ex. : misoprostol ou inhibiteurs de la pompe de protons) devra être pondérée pour ces patients, ainsi que pour ceux devant simultanément prendre l'acide acétylsalicylique à de faibles doses, ou d'autres médicaments pouvant augmenter le risque d'ulcère ou d'hémorragie, comme les corticostéroïdes, les anticoagulants (comme la warfarine), les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ou des antiagrégants plaquettaires, comme l'acide acétylsalicylique (voir section 4.5). Interrompre le traitement en cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'ulcération chez les patients prenant RANTUDIL 90 Retard.

Les AINS doivent être administrés avec précaution chez les patients ayant une histoire de maladie inflammatoire de l'intestin (colite ulcéreuse, maladie de Crohn), dans la mesure où ces situations peuvent être exacerbées (voir section 4.8).

Effets hépatiques

Un contrôle médical rigoureux est nécessaire lors de la prescription de RANTUDIL 90 Retard chez les patients souffrant d'insuffisance hépatique. En effet, leur condition pourra être exacerbée. Comme tout autre AINS, des augmentations des niveaux d'une ou de plusieurs enzymes hépatiques pourront survenir. Lors d'un traitement de longue durée avec RANTUDIL 90 Retard, il est conseillé un contrôle fréquent de la fonction hépatique, en tant que mesure de précaution. Si les tests de la fonction hépatique restent anormaux ou se détériorent, s'il apparaît des signes ou symptômes cliniques suggérant une maladie hépatique ou s'il se produit d'autres phénomènes (par exemple, éosinophilie, l'exanthème, etc.), il convient d'interrompre l'administration de RANTUDIL 90 Retard. Une hépatite peut survenir en l'absence de symptômes prodromiques.

Effets rénaux

À cause des cas rapportés d'œdème ou de rétention de liquides découlant de la thérapeutique à base d'AINS, porter une attention particulière aux patients souffrant d'insuffisance cardiaque ou rénale, ayant un historique d'hypertension, aux personnes âgées, aux patients recevant un traitement concomitant à base de diurétiques ou de médicaments pouvant considérablement modifier la fonction rénale (voir section 4.3).

Ainsi, et dans ces situations, on recommande, à titre de précaution, de contrôler la fonction rénale en cas de prise de RANTUDIL 90 Retard. L'interruption de la thérapeutique est normalement suivie d'un retour à l'état de prétraitement.

Effets hématologiques

De même que les autres AINS, et en cas de traitement de longue durée par le RANTUDIL 90 Retard, il est recommandé de faire un contrôle sanguin.

Comme c'est le cas pour les autres AINS, RANTUDIL 90 Retard peut temporairement inhiber l'agrégation plaquettaire. Une surveillance attentive s'impose chez les patients présentant de troubles de l'hématose.

Des réactions adverses cutanées graves, dont certaines fatales, y compris la dermatite exfoliative, un syndrome de Stevens-Johnson et une nécrolyse épidermique toxique, ont été très rarement signalées comme conséquence d'un traitement par des AINS (voir rubrique 4.8). Apparemment, le risque de survenue de ces réactions est plus élevé au début du traitement. Ainsi, dans la plupart des cas, ces réactions se manifestent au cours du premier mois de traitement, menant à l'arrêt de RANTUDIL 90 Retard dès l'apparition des premiers symptômes d'éruption, de lésions muqueuses ou d'autres réactions d'hypersensibilité.

Effets cardiovasculaires et cérébrovasculaires

Des cas de rétention de liquides et d'œdème associés au traitement par AINS ont été rapportés. Ainsi, une surveillance adéquate et des recommandations sont requises chez les patients présentant des antécédents d'hypertension artérielle et/ou d'insuffisance cardiaque congestive légère à modérée.

Les données des études cliniques et épidémiologiques suggèrent que l'administration de certains AINS (notamment à des doses élevées et pendant un traitement de longue durée) peut être associée à une légère augmentation du risque d'événements thrombotiques artériels (par exemple, infarctus du myocarde ou AVC). Il n'y a pas de données suffisantes pour éliminer le risque de survenue de ces effets lors de l'utilisation de l'acémétacine.

Les patients présentant une hypertension artérielle non contrôlée, une insuffisance cardiaque congestive, une cardiopathie ischémique établie, une maladie artérielle périphérique et/ou de maladie cérébrovasculaire ne devront être traités par l'acémétacine qu'après un examen attentif. Des précautions similaires doivent être portées avant toute initiation d'un traitement à long terme chez les patients présentant des facteurs de risques cardiovasculaires (ex. : hypertension artérielle, hyperlipidémie, un diabète mellitus ou une consommation tabagique).

Asthme préexistant

Les réactions aux AINS, comme les exacerbations asthmatiques, l'œdème de Quincke ou l'urticaire sont plus fréquentes chez les patients atteints d'asthme, de rhinite allergique saisonnière, d'inflammation des muqueuses nasales (p. ex. polypes nasaux), de maladies pulmonaires obstructives chroniques ou d'infections chroniques du tract respiratoire (surtout si celles-ci s'accompagnent de symptômes similaires à ceux de la rhinite allergique) que chez les autres patients. Dès lors, il est recommandé une attention particulière chez ces patients (mesures d'urgence). Cela s'applique également aux patients qui présentent une allergie à d'autres substances, comme les réactions cutanées, le prurit ou l'urticaire.

RANTUDIL 90 Retard ne doit être pris qu'après une évaluation attentive du bénéfice-risque chez les patients atteints de lupus érythémateux systémique (LES) ou de maladies mixtes du tissu conjonctif. En effet, il peut y avoir un risque accru de méningite aseptique.

Ne pas prendre de doses de RANTUDIL 90 Retard supérieures à celles recommandées. La prise de RANTUDIL 90 Retard n'est pas recommandée aux enfants et adolescents de moins de 14 ans.

Éviter l'administration concomitante de RANTUDIL 90 Retard avec d'autres AINS, y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2.

Tout comme avec un AINS, l'acémétacine peut masquer les signes et symptômes d'une infection.

Des altérations oculaires pourront survenir, lesquelles seront plus fréquentes chez les patients atteints d'arthrite rhumatoïde. Ainsi, en cas de traitement prolongée, consultez votre ophtalmologue et interrompez le traitement en cas de manifestation.

Des cas d'hypercalcémie ont été rapportés chez les patients traités à l'indométacine et à l'acémétacine. Ainsi, ce facteur devra être pris en compte pour les cas d'utilisation de diurétiques épargneurs de potassium.

RANTUDIL 90 Retard contient du lactose monohydraté. Les patients ayant des problèmes héréditaires rares d'intolérance au galactose, un trouble de lactase ou de malabsorption de glucose-galactose ne devront pas prendre ce médicament.

RANTUDIL 90 Retard contient de la tartrazine (E102), pouvant provoquer des réactions allergiques.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction

Les interactions suivantes comprennent celles qui ont été observées avec RANTUDIL 90 Retard.

Lithium

En cas d'utilisation simultanée, l'acémétacine peut augmenter la concentration plasmatique de lithium. Il convient de contrôler les niveaux sériques de lithium.

Digoxine

En cas d'utilisation simultanée, l'acémétacine peut augmenter la concentration plasmatique de la digoxine. Il convient de contrôler les niveaux sériques de la digoxine.

Corticostéroïdes

Augmentation du risque d'ulcération ou d'hémorragie gastro-intestinale (voir section 4.4).

Autres AINS et corticostéroïdes

L'administration concomitante d'acémétacine et d'autres AINS systémiques ou corticostéroïdes peut augmenter l'incidence d'effets indésirables gastro-intestinaux (voir section 4.4).

Anticoagulants

Les AINS peuvent augmenter les effets des anticoagulants, tels que la warfarine (voir section 4.4).

Agents antiagrégants plaquettaires et inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine

Augmentation du risque d'hémorragie gastro-intestinale (voir section 4.4).

Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA) et antagonistes de l'angiotensine II (AAII)

Les anti-inflammatoires non-stéroïdes (AINS) peuvent réduire l'efficacité des diurétiques ainsi que celle d'autres médicaments antihypertenseurs. Chez certains patients dont la fonction rénale est réduite (ex. : patients déshydratés ou personnes âgées dont la fonction rénale est compromise), la coadministration d'un IECA ou AAII et d'agents inhibiteurs de la cyclo-oxygénase peut mener à la progression de la détérioration de la fonction rénale, y compris la possibilité d'insuffisance rénale aigüe, laquelle est normalement réversible. La survenue de ces interactions devra être prise en compte pour les patients prenant l'acémétacine en association avec l'IECA ou AAII. Par conséquent, cette association médicamenteuse devra être administrée avec précaution, surtout chez les patients âgés. Les patients doivent être suffisamment hydratés. De même, leur fonction rénale doit être contrôlée après l'instauration du traitement concomitant que périodiquement par la suite.

Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRSs)

L'administration concomitante d'AINS et d'ISRSs peut augmenter le risque d'hémorragie gastro-intestinale (voir rubrique 4.4).

Méthotrexate

Une précaution particulière est recommandée lorsque les AINS sont administrés moins de 24 heures avant, ou suite à un traitement par le méthotrexate étant donné que la concentration sanguine de méthotrexate peut augmenter, stimulant ainsi la toxicité de cette substance.

Cyclosporine et tacrolimus

L'effet de l'acémétacine et d'autres AINS sur les prostaglandines rénales peut être à l'origine d'une augmentation de la néphrotoxicité de la cyclosporine et du tacrolimus. C'est pourquoi il convient d'administrer une dose d'acémétacine moins élevée que chez un patient ne prenant pas de cyclosporine ou de tacrolimus.

Antibactériens du groupe des quinolones

Des cas isolés de convulsions ont été rapportés - probablement à cause d'un traitement simultané par des quinolones et des AINS.

Probénécide

Le probénécide peut réduire l'excrétion des AINS, augmentant ainsi leurs niveaux plasmatiques et la possibilité d'effets indésirables.

Étant donné que l'acémétacine s'associe aux protéines plasmatiques, bien qu'en moindre degré que les autres anti-inflammatoires non-stéroïdiens, il est possible de déplacer cette liaison d'autres médicaments, notamment des sulfonylurées, hydantoïne et phénylbutazone, augmentant éventuellement et de manière transitoire, les niveaux plasmatiques de la forme libre de ces médicaments.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse

L'inhibition de la synthèse des prostaglandines peut avoir une influence négative sur la grossesse et/ou sur le développement embryonnaire et foetale. Des données tirées d'études épidémiologiques suggèrent un risque accru de fausses couches, de malformations cardiaques et de gastroschisis après l'utilisation d'inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines en début de grossesse. Le risque absolu de malformation cardiovasculaire est passé de moins de 1% à environ 1,5%. L'on présume que le risque augmente avec la dose et la durée du traitement.

L'administration d'inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines chez des animaux a entraîné une hausse de la perte pré- et post-implantation et de la létalité embryo-fœtale.

En outre, dans un dosage *in vitro* en culture de cellules embryonnaires de rats, une incidence accrue de diverses malformations, y compris des malformations cardiovasculaires chez des animaux qui avaient reçu un inhibiteur de la synthèse des prostaglandines, a été rapporté. Dans des essais précliniques standards chez les animaux, aucune preuve n'a été trouvée quant au potentiel tératogène de l'acémétacine chez les souris, les rats ou les lapins.

Au cours des premier et deuxième trimestres de la grossesse, RANTUDIL 90 Retard ne doit pas être utilisé sauf en cas de nécessité absolue. En cas d'administration aux femmes essayant de tomber enceintes, ou au cours du premier et deuxième trimestre de la grossesse, il convient de maintenir la dose aussi basse que possible et de limiter le plus possible la durée du traitement.

Au cours du troisième trimestre de la grossesse, tous les inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines peuvent exposer le fœtus à :

- une toxicité cardiopulmonaire (fermeture prématurée du *ductus arteriosus* (canal de Botal) et hypertension pulmonaire)

- une dysfonction rénale pouvant évoluer jusqu'à une insuffisance rénale avec oligoamnios.

Au cours de la dernière phase de grossesse, la mère et le nourrisson pourront être exposés à :

- une éventuelle prolongation du temps de saignement, un effet antiagrégant qui peut survenir même à très faibles doses.

- une inhibition de la contraction de l'utérus entraînant un retard ou prolongation du travail d'accouchement.

En conséquence, l'administration de RANTUDIL 90 Retard est contre-indiquée au cours du troisième trimestre de la grossesse.

Allaitement

Comme d'autres AINS, l'acémétacine passe dans le lait maternel en faibles doses. C'est pourquoi RANTUDIL 90 Retard ne doit pas être administré pendant l'allaitement, afin d'éviter des effets indésirables chez le nourrisson.

Fertilité

Tout comme les autres AINS, l'utilisation de RANTUDIL 90 Retard peut nuire à la fertilité féminine. Aussi, n'est-il pas recommandé chez les femmes qui envisagent une grossesse. Chez les femmes qui ont des difficultés à être enceintes ou subissent un examen de fertilité, il convient d'envisager l'arrêt du traitement par RANTUDIL 90 Retard.

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Les effets de RANTUDIL 90 Retard sur la capacité à conduire et utiliser des machines sont nuls ou négligeables.

4.8 Effets indésirables

La fréquence a été définie comme suit :

[Très fréquents ($\geq 1/10$), Fréquents ($\geq 1/100$, $< 1/10$), Peu fréquents ($\geq 1/1.000$, $< 1/100$), Rares ($\geq 1/10.000$, $< 1/1.000$), Très rares ($< 1/10.000$, inconnu (ne peut être calculé à partir des données disponibles))]

Affections du système nerveux

Rares : céphalées, vertiges, troubles transitoires de la vue et de l'audition.

Affections gastro-intestinales

Les événements adverses observés le plus fréquemment sont de nature gastro-intestinale. Les personnes âgées pourront notamment souffrir d'ulcères peptiques, de perforation ou d'hémorragie gastro-intestinale potentiellement fatale (voir section 4.4). Des cas de nausées, de dyspepsie, de vomissements, d'hématémèses, de flatulences, de douleurs abdominales, de diarrhée, de constipation, de méléna, de stomatite aphteuse, d'exacerbation de colite ou de la maladie de Crohn (voir section 4.4) ont été rapportés suite à l'administration de ces médicaments. Des cas de gastrite ont été observés moins fréquemment.

Affections hépatobiliaires

Élévation occasionnelle des paramètres de laboratoire de la fonction hépatique.

Très rares : Symptômes de cholestase.

Affections cardiaques

Des cas d'œdème, d'hypertension et d'insuffisance cardiaque ont été rapportés pendant le traitement par les AINS.

Les données des essais cliniques et épidémiologiques suggèrent que l'administration de certains AINS (notamment à des doses élevées et en traitement de longue durée) pourra être associée à une légère hausse du risque d'événements thrombotiques artériels (par exemple, infarctus du myocarde et AVC) (voir section 4.4).

Affections hématologiques et du système lymphatique

Rarement, thrombopénie, leucopénie et réduction des niveaux d'hémoglobine.

Très rares : agranulocytose réversible et dépression de la moelle osseuse.

Affections de la peau et du tissu sous-cutané

Très rares : Éruptions bulleuses, y compris le syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique.

Affections oculaires/affections de l'ouïe et du labyrinthe

Peu fréquents : tinnitus, vision trouble, douleur oculaire.

4.9 Surdosage

Le traitement d'une intoxication aiguë par l'acémétacine consiste essentiellement en :

- a) éviter l'absorption de la dose n'ayant pas encore été absorbée
- b) augmenter l'élimination de celle absorbée
- c) corriger les autres écarts existants, pouvant mettre en danger la vie du patient intoxiqué.

Pour prévenir la résorption de l'acémétacine n'ayant pas encore été absorbée, procéder à une vidange gastrique, que ce soit par un lavage gastrique (surtout si le patient est inconscient) ou par l'induction de vomissement (si le patient est conscient). En cas de lavage gastrique, prévenir l'éventuelle aspiration du vomissement, à l'aide d'une intubation endotrachéale. Ces mesures ne seront pertinentes que si elles sont effectuées 3 à 4 heures suivant l'ingestion de la dose toxique. Procéder également à l'administration de liquides et d'électrolytes, en fonction de la situation clinique du patient intoxiqué et conformément aux normes usuelles de correction des troubles hydroélectrolytiques. D'autres mesures générales de soutien pourront également s'avérer nécessaires.

Aucun antidote spécifique n'est connu pour l'acémétacine.

5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

5.1. Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique : 9.1.5 - Appareil locomoteur. Anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Dérivés de l'indol et de l'indène.

Code ATC : M01AB11

L'acémétacine est un anti-inflammatoire non-stéroïdien du groupe des dérivés indoliques. L'indométacine, médicament standard de ce groupe, est l'un des anti-inflammatoires les plus étudiés, étant ainsi une référence dans les essais de nouveaux anti-inflammatoires. Cette vaste utilisation permet de documenter son efficacité, ainsi que son incidence appréciable d'effets indésirables suite à la prise d'indométacine. L'acémétacine est un dérivé indolique synthétisé prétendant réduire l'incidence de ces effets indésirables, tout en préservant son efficacité. La vaste expérience clinique accumulée avec l'administration de ce traitement, ainsi que la bibliographie scientifique qui lui est dédiée, confirment la réalisation de ce desideratum. Les actions pharmacologiques les plus importantes de l'acémétacine sont celles mentionnées ci-après. L'acémétacine montre une activité anti-inflammatoire plus intense que l'indométacine. La DE50 (dose efficace 50) est 1 à 4 fois celle de l'indométacine sur les modèles expérimentaux étudiés - nystatine, concanavaline A, levures, formol, carraghénine, kaolin. Il en est de même pour l'arthrite par adjuvant de Freund et le test de Mizushima. Au contraire, l'acémétacine est peu puissante en tant qu'inhibiteur de la synthèse de prostaglandines (environ 30 fois moins puissante que l'indométacine).

L'activité anti-inflammatoire découle de l'association de plusieurs actions que ce dérivé indolique exerce à différentes phases de la réaction inflammatoire, produisant ainsi une inhibition de libération d'enzymes lysosomales, d'activation d'enzymes protéolytiques, de libération de l'histamine des mastocytes, de libération de la bradycinine et de la sérotonine, du complément, de l'exsudation et de la migration leucocytaire. Elle est en outre responsable de l'inhibition du système de la cyclo-oxygénase, avec action préférentielle sur la COX 2.

L'action analgésique est également bien documentée par la preuve de benzoquinone et le test de Randall Selitto, ainsi que par les nombreuses études cliniques.

L'administration chronique ne conditionne pas la tolérance ni la dépendance.

5.2. Propriétés pharmacocinétiques

L'acémétacine est presque complètement résorbée par voie orale (presque 100% de biodisponibilité). Les concentrations maximales sont atteintes environ 2 heures suivant l'administration.

Rantudil 90 Retard contient, pour chaque gélule à libération prolongée, 90 mg d'acémétacine (30 mg sous forme conventionnelle, d'absorption rapide, et 60 mg sous forme d'action prolongée, afin de ralentir l'absorption). Cette préparation ne modifie pas la biodisponibilité, permettant ainsi d'obtenir rapidement des concentrations efficaces, tout en augmentant environ quatre fois la demi-vie de l'absorption.

L'acémétacine est partiellement éliminée par voie rénale, de manière libre, glucuroconjugée, ou transformée en indométacine et métabolites O-déméthylés et N-désacylés (libres et conjugués). L'acémétacine et ses métabolites sont également partiellement excrétés par voie biliaire et éliminés dans les fèces. L'élimination biliaire s'effectue essentiellement sous forme d'acémétacine libre et glucuroconjugée. Il n'y a pas d'induction d'enzymes métabolisatrices, même en cas de traitement prolongé. Les administrations répétées conditionnent des niveaux plasmatiques plus élevés. Ainsi, l'équilibre est établi au bout d'environ 7 jours, ne constatant aucune accumulation ultérieure.

Suite à l'administration unique ou continuée, la relation entre les concentrations sanguines du médicament intact et de l'indométacine découlant de sa métabolisation est de 1:1. Les concentrations de l'acémétacine dans le liquide synovial et la membrane synoviale sont respectivement 2 et 4 fois supérieures à celles rencontrées dans le plasma.

5.3 Données de sécurité préclinique

La toxicité aigüe de l'acémétacine est faible. La DL50 pour l'administration orale a été étudiée chez la souris, le rat, le lapin, le cochon d'Inde et le chat, variant entre 30 et 600 mg/Kg.

Chez le chien, les doses de 2,5 mg/Kg/jour ont entraîné la mort de certains des animaux à la 4ème, 5ème, 6ème et 7ème semaine suivant le début du traitement.

Les animaux traités avec une dose de 0,28 mg/kg/jour n'ont présenté aucune modification (du développement, des paramètres hématologiques ou biochimiques).

Chez le singe, l'administration *per os* de 18 mg/kg/jour d'acémétacine pendant 8 semaines n'a eu aucune influence sur la mortalité, le poids et l'histologie des organes.

Lors de ces études précliniques effectuées pour déterminer la toxicité du médicament, aucun autre effet adverse n'a été trouvé.

Chez les rats traités pendant la gestation avec 3,6 mg/jour, on n'a observé aucune modification du nombre de nasciturus par portée, ni aucune malformation.

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Polyvidone K 25

Crospovidone

Acétate phtalate de cellulose

Triacétine

Dioxyde de titane (E171)
Lactose monohydraté
Stéarate de magnésium
Silice colloïdal anhydre
Talc

Gélule :
Gélatine
Érythrosine (E127)
Tartrazine (E102)
Dioxyde de titane (E171)
Eau purifiée
Jaune de quinoléine (E104)
Indigotine (E132)

6.2 Incompatibilités

Sans objet.

6.3 Durée de conservation

3 ans.

6.4 Précautions particulières de conservation

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

6.5 Nature et contenu de l'emballage extérieur

Boîte en carton contenant une notice et 10, 30, 60 ou 90 gélules à libération prolongée, conditionnées sous blister en PVC/aluminium.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

6.6 Précautions particulières d'élimination et manipulation

Pas d'exigences particulières.

7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Bial- Portela & C^a, S.A..
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugal

8. NUMÉROS DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Décisión nº 2016-01599

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

Version N.1.0 (2016.11.01)

Initial Marketing Authorisation

Date de première autorisation: 2016.11.01

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE